外科学 外科总论

核心精讲·感染

（性感认识：本章应具备对比意识）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、外科感染概述

①外科感染约占外科疾病的 1/3-1/2，外科感染常为多种细菌的混合感染

②病程：急性、亚急性（3 周-2 个月）、慢性 VS非特异性感染:金葡菌可以导致肺炎、乳腺炎、骨髓炎

③**特异性感染**：结核（只会导致结核）、破伤风（只会导致破伤风）、气性坏疽、真菌如念珠菌感染（凤姐真坏）

④条件/机会感染：平时非致病的病原菌趁机体抵抗力下降时引起感染，如院内感染　HIV时70%患者容易发生孢子虫肺炎,中枢易以新隐球菌、弓形虫、巨细胞病毒多见

⑤**二重感染/菌群交替**：长期广谱抗生素抑制敏感菌、不敏感菌（假丝酵母菌/念珠菌多见）趁机生长繁殖引起感染

⑥外科用抗生素的原则：　一个脓点

不是所有外科感染都要用	如表浅且局限的疖不用抗生素（用理疗、敷贴中药金黄散、鱼石脂软膏金龙鱼）
用药也不能减免外科处理	**去除感染灶+通畅引流是外科治疗基本原则** eg.脓胸最基本治疗:引流
有明确指征才预防性用药 eg.急性阑尾炎做外科手术需要预防性用抗生素	如麻醉开始或术前 0.5-2h 首次给药，手术＞3h 或失血＞1500 术中可给第二剂，总预防用药＜24-48 小时
联合用药要有明确指征	病因未明、或免疫缺陷者的严重感染 单一抗菌药不能控制的混合感染（如脓毒症、继发性腹膜炎、感染性心内膜炎） 需长时间用药、病原菌易耐药的感染（如结核、尿路感染）长期低剂量用药（早恋全是短命鬼） 减少个别药物剂量以降低毒性反应（如两性霉素 B+氟胞嘧啶治疗真菌感染）

常见致病菌是草绿色链球菌(用青霉素G),会联合氨基糖苷类抗生素(大肠杆菌菌血症很常见,但粘附差)

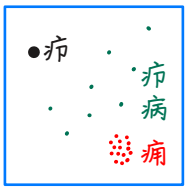
二、浅部组织感染

（一）概述

金葡菌	乙型溶血性链球菌
产生凝血酶使渗出的纤维蛋白原转变为纤维蛋白 →感染较局限 易形成脓肿	产生透明质酸酶使结缔组织的透明质酸降解 →感染弥漫
多见于疖、痈等	多见于蜂窝织炎、丹毒等
抗生素多用青霉素类、头孢菌素类	

（二）疖、痈

1.疖：1 个脓点。出现波动感→碘伏点涂、剔除脓栓





2.痈

①多个相邻毛囊及其周围组织化脓性炎（多个相邻脓点）

②好发于**项背部**（搭背），多合并**糖尿病**　眼V、内眦V均没有静脉瓣,容易发生逆流

③若发生在**危险三角如唇痈：严禁挤压和切开，否则可致海绵状静脉窦炎（头痛、意识障碍）**

④**出现波动感：切开引流（十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔）**，清除已化脓和尚未化脓但已失活的组织　填塞生理盐水、碘伏、凡士林纱条

